



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

FAILURE MODE EFFECT ANALYSIS (FMEA)

**RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
SUKOREJO
TAHUN 2025**

Jl. Raya Surabaya – Malang No. KM 54, Surabaya – Pasuruan

Telp. 08341 – 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN

Failure Mode Effect Analysis (FMEA)

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Tahun 2025

Hasil *Failure Mode Effect Analysis* (FMEA) RS. Prima Husada Sukorejo tahun 2025 dengan pemilihan tema “Manajemen Risiko di Instalasi Farmasi” dengan sub tema adalah “Proses Penerimaan Barang dari distributor”.

Disusun,

Oleh :

Kepala Instalasi Farmasi RS. Prima Husada



(Apt. Laili Choirul Umma, S. Farm)

Disetujui oleh,
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah M. Kes., AFP)

Disetujui,
Oleh

Direktur RS. Prima Husada



(Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep, M. Kep)

KATA PENGANTAR

Keselamatan (*safety*) telah menjadi isu global, termasuk juga di dalam ranah pelayanan di Rumah Sakit. Keselamatan (*safety*) tidak hanya diperuntukan kepada pasien (*patient safety*) namun juga mencakup keselamatan pekerja atau petugas kesehatan, keselamatan bangunan dan peralatan di rumah sakit yang dapat berdampak pada keselamatan pasien dan petugas, dan keselamatan lingkungan yang berdampak pada pencemaran lingkungan dan keselamatan yang terkait dengan kelangsungan hidup Rumah sakit. Keselamatan pasien merupakan prioritas utama ditegakkan, hal ini dikarenakan berkaitan dengan isu mutu dan citra Rumah Sakit.

Dalam rangka meningkatkan peningkatan Keselamatan pasien, petugas, maupun peralatan yang ada di Rumah Sakit, perlu dilakukan analisis untuk memperbaiki kinerja maupun proses kinerja melalui identifikasi atau mencegah potensi kegagalan sebelum terjadinya insiden. Kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di setiap unit dapat diprediksi dan diantisipasi melalui *Failure Mode and Effects Analysis* sehingga dampak buruk akibat dari kesalahan tersebut dapat dihilangkan atau diminimalisir.

Semoga dengan adanya hasil *Failure Mode and Effects Analysis* ini dapat menjadikan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya insiden yang terjadi di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN..... 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI..... 3

BAB I..... 4

PENDAHULUAN 4

BAB II..... 5

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN..... 5

2.1 Pemilihan Proses Berisiko Tinggi5

2.2 Penyusunan Tim8

2.3 Grafik Alur Proses dan Brainstorming Modus Kegagalan.....9

2.4 Menentukan Dampak..... 25

2.5 Prioritas Modus Kegagalan..... 28

BAB III25

PENUTUP.....25

BAB I

PENDAHULUAN

Manajemen logistik merupakan bagian dari *supply chain managemet* yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengimpelementasian, dan pengontrolan secara efektif dan efisien terhadap arus barang yang masuk dan keluar serta penyimpanan barang, jasa, serta informasi terkait antara titik asal dengan titik konsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan (Hendayani, 2011).

Logistik merupakan suatu ilmu pengetahuan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan serta penghapusan materi atau alat-alat. Lebih lanjut, logistik diartikan bagian dari instansi yang bertugas menyediakan bahan atau barang yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional suatu instansi dalam jumlah, kualitas dan pada waktu yang tepat (sesuai kebutuhan) dengan harga serendah mungkin.

Bagian logistik farmasi adalah bagian dari unit pelayanan farmasi rumah sakit yang berfungsi sebagai sarana pengelola perbekalan farmasi yang digunakan di rumah sakit. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai merupakan suatu siklus kegiatan dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, pemusnahan dan penarikan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan.

Banyaknya ketidakpastian dalam rantai pasok sediaan farmasi dapat menimbulkan risiko yang tinggi pula, termasuk pada rantai pasok sediaan farmasi di RS Prima Husada, oleh sebab itu manajemen risiko rantai pasok farmasi menjadi penting dilakukan untuk menjaga ketersediaan obat. Berdasarkan kondisi tersebut, rumah sakit melakukan analisis terkait manajemen risiko pada sistem pelayanan kesehatan berupa akses terhadap sediaan farmasi.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Memberikan pemahaman bagi staff tentang manajemen risiko logistik farmasi di Gudang Farmasi Rumah Sakit Prima Husada.

1.3.2 Tujuan Khusus

Mengetahui faktor – faktor risiko apa saja yang mempengaruhi ketersediaan logistik farmasi di Rumah Sakit Prima Husada.

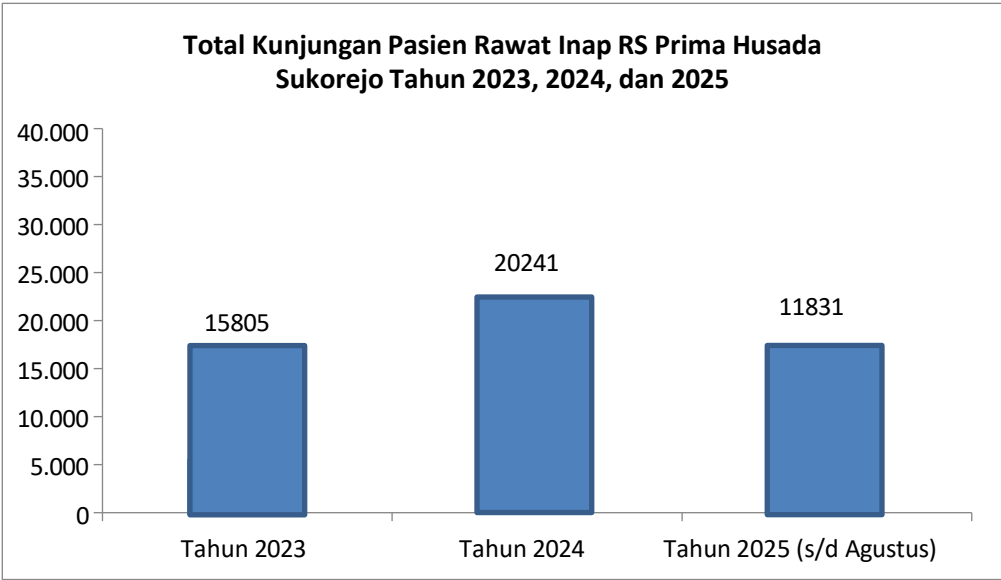
BAB II
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Pemilihan Proses Berisiko Tinggi

Failure Mode and Effects Analysis (Selanjutnya disebut FMEA) adalah proses proaktif dalam memperbaiki kinerja dengan mengidentifikasi dan mencegah potensi kegagalan sebelum terjadi, dimana kesalahan dapat diprediksi dan diantisipasi sehingga dampak buruk akibat kesalahan itu dapat dihilangkan atau diminimalisir demi keselamatan pasien. Proses yang ditetapkan untuk dilakukan analisis FMEA yakni proses pengadaan dan distribusi di unit Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo,

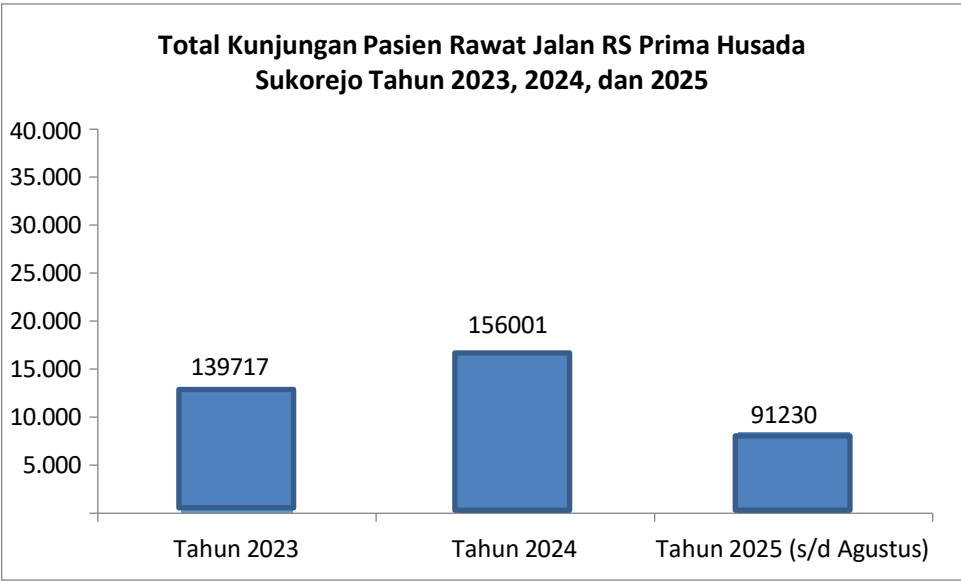
Berdasarkan data kunjungan pada tahun 2023- berjalan 2025. Kunjungan pasien rawat inap Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Meningkat sebanyak 128% dari tahun 2023 ke tahun 2024. Berdasarkan gambaran peningkatan kunjungan pasien rawat inap Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yang meningkat di tahun 2024, dari 15805 kunjungan, meningkat menjadi 20241, angka komplain terhadap pelayanan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo juga tentunya akan meningkat. Gambaran total kunjungan ditunjukkan sebagai berikut :

Grafik 2.1 Gambaran kunjunga pasien Rawat Inap
Instalasi Farmasi RS. Prima Husada Sukorejo dari tahun
2023 - 2025



Berdasarkan data kunjungan pada tahun 2023 – 2024, kunjungan pasien rawat jalan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo meningkat sebanyak 111% dari tahun 2023 ke tahun 2025. Namun, jumlah kunjungan mengalami penurunan pada tahun 2025 dikarenakan PRB. Angka komplain terhadap pelayanan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo juga akan tetap terjadi. Gambaran total kunjungan ditunjukkan sebagai berikut :

Grafik 2.2 Gambaran kunjungan pasien Farmasi Rawat Jalan RS. Prima Husada Sukorejo dari tahun 2023 - 2025



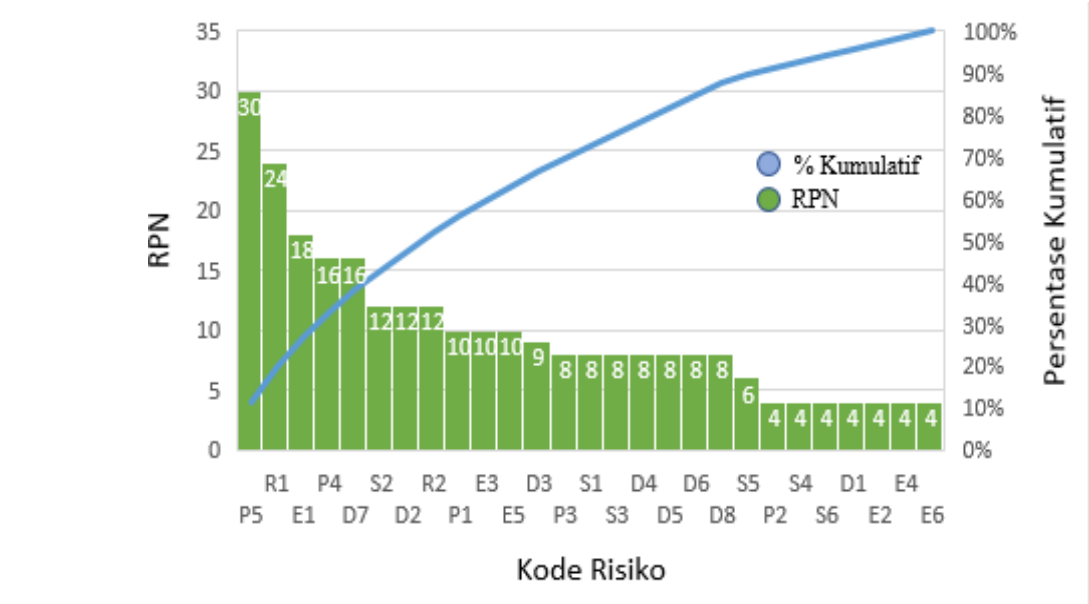
Semakin banyaknya pasien yang berkunjung di suatu unit, maka risiko untuk terjadi komplain maka akan semakin tinggi. Salah satu risiko komplain yang mungkin terjadi yakni ketersediaan obat di rumah sakit. Bahkan tidak hanya komplain risiko lainnya juga akan timbul, baik risiko yang sudah terjadi maupun belum terjadi. Berikut merupakan gambaran daftar risiko yang mungkin terjadi di Instalasi Farmasi Depo Gudang Farmasi.

Penilaian risiko yang dilakukan menggunakan nilai reliability indikator dampak (*severity*), probabilitas kejadian (*occurrence*), dan kontrol deteksi (*detection*)

Tabel 2.1 Daftar Risiko Gudang Farmasi Tahun 2025

Kode	Kinerja	Potensi Risiko	S	O	D	RPN
P1	Reliability	Kesalahan <i>forecasting</i> jumlah permintaan	5	1	2	10
P2	Reliability	Perencanaan stok produk yang tidak tepat	2	2	1	4
P3	Agility	Perubahan permintaan secara mendadak	2	2	2	8
P4	Cost	Anggaran kegiatan operasional RS lebih besar dari pendapatan	4	1	1	4
S1	Responsiveness	Keterlambatan pengiriman produk dari vendor	4	2	1	8
S2	Reliability	Kerusakan produk dalam perjalanan pengiriman ke RS	3	2	2	12
S3	Reliability	Kesalahan pengiriman jumlah, jenis, dan dosis obat	4	2	1	8
S4	Cost	Vendor mengirimkan produk dengan tanggal <i>expired</i> terlalu dekat	4	1	1	4
S5	Reliability	Tidak ada stok produk di RS	3	2	1	6
S6	Reliability	Dokumen penunjang pengiriman produk tidak lengkap (SKB tidak lengkap)	2	2	1	4
D1	Reliability	Kesalahan alamat pengantaran	4	1	1	4
D2	Reliability	Kerusakan produk di perjalanan	3	2	2	12
D3	Responsiveness	Keterlambatan pengiriman produk ke RS	3	1	3	9
D4	Reliability	Keterbatasan stok produk di vendor	2	2	2	8
D5	Reliability	Kesalahan penulisan dosis obat di <i>Invoice</i>	4	2	1	8
D6	Cost	Terjadi kecelakaan ringan saat pengantaran produk ke <i>customer</i> (jalur darat)	2	2	2	8

D7	Reliability	Kesalahan pengiriman produk	4	2	2	16
D8	Reliability	Petugas logistik lupa memasukkan dokumen <i>delivery order</i> ke dalam <i>box</i> pesanan	2	2	2	8
D9	Responsiveness	Kekurangan jumlah petugas gudang	5	2	3	30
R1	Reliability	Pengembalian produk oleh karena adanya perubahan stabilitas produk	3	2	2	24
R2	Reliability	Pengembalian produk <i>recall</i>	3	3	2	12
E1	Asset Management	Kesulitan mencari arsip dokumen yang diperlukan untuk pembuatan laporan logistik RS	2	1	2	18
E2	Cost	Adanya data <i>finance</i> yang terlewatsaat menginput data menggunakan SIMRS	5	1	2	4
E3	Reliability	Terjadi masalah pada komputer	2	2	1	10
E4	Reliability	Terjadi <i>error</i> /data tidak tersimpansaat menginput data di sistem SIMRS	4	1	1	4
E5	Reliability	Adanya data yang tidak sesuai ketika rekap data stok barang ke sistem komputer (terjadi selisih stok)	5	2	1	10
E6	Cost	Fasilitas penyimpanan tidak optimal	4	1	1	4



Pareto Chart

Berdasarkan tabel daftar risiko diatas dapat disimpulkan bahwa dari beberapa daftar risiko yang di miliki, Proses penerimaan Barang dari distributor memiliki peringkat risiko paling tinggi.

Proses Penerimaan Barang dari distributor merupakan salah satu hal penting yang pasti terjadi pada pasien di sebuah Rumah Sakit. Penerimaan Barang adalah menjamin mutu dan kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai berdasarkan Surat pemesanan dan faktur yang dilakukan dengan distributor resmi yang sudah melakukan kerjasama dengan RS Prima Husada. Penerimaan harus menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima.

Berdasarkan data pendukung yang dimiliki Rumah Sakit Prima Husada Menentukan topik yang akan di bahas pada analisis FMEA tahun 2025 di Gudang Farmasi yakni Proses Penerimaan Barang dari distributor.

2.2 Penyusunan Tim

Tabel 2.2 Pembentukan Tim FMEA 2025 RS. Prima Husada Sukorejo

Judul Proses Berisiko Tinggi	:	Proses pengiriman dan penerimaan Barang dari Distributor	
Tanggal Dimulai	:	Januari 2025	
Tanggal Selesai	:	Desember 2025	
Unit Terkait	:	Instalasi Farmasi	
Pembentukan Tim			
Ketua Tim	:		Ka. Bidang Penunjang Medis
Anggota	:	apt. Laili Choirul Umma, S. Farm	Kepala Instalasi Farmasi
Anggota	:	apt. Ramadhan Riski Putranto, S. Farm	PJ Rawat Inap
Anggota	:	apt. Yolanda Riskawasianda Y, S. Farm	PJ Rawat Jalan
Anggota	:	Sintia Anggriani, A.md.Kes	PJ Gudang Farmasi
Anggota	:	apt. Dita Nurul Aini, S. Farm	Sekretaris KFT
Anggota	:	Ayu Indria Irmia, A.Md.Farm	Tenaga Vokasi Farmasi
Keterwakilan anggota Tim sesuai batasan kasus	:	Ya / Tidak—	
Keterlibatan pasien dalam tim	:	Tidak	

Tabel 2.3 Time Line Tim FMEA

No	Judul Kegiatan	Tanggal pelaksanaan									
		Tahun 2025									
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt
1	Identifikasi topik dan penentuan tim FMEA 2025										
2	Mengambaran proses topik terpilih										
3	Melakukan identifikasi sub proses										

4	Mengunjungi unit terkait untuk mengobservasi topik / proses yang dipilih (monitoring proses / sub proses apakah sudah benar / sesuai?)										
5	Brainstorming modus kegagalan dan penyebabnya dengan tim FMEA 2025										
6	Menuliskan pada format lembar kerja HFMEA										
7	Menganalisis hazard yang mungkin terjadi										
8	Mengidentifikasi tindakan perbaikan dan menentukan tindak lanjut										
9	Hasil tindak lanjut mulai diberlakukan di unit										
10	Uji perbuhanan yang diberlakukan										
11	Pertemuan ketua tim FMEA dengan Pimpinan untuk persetujuan semua tindakan perbaikan										

Tabel 2.4 Alur Proses pengiriman dan penerimaan Barang dari Distributor

1	2	3	4
Petugas Gudang Farmasi melakukan proses pemesanan di distributor	Distributor melakukan pengiriman barang	Petugas Gudang Farmasi melakukan proses penerimaan barang	Jika sudah sesuai, petugas gudang melakukan ttd penerimaan barang pada faktur
1. Melakukan perhitungan kebutuhan		1. Petugas Gudang Farmasi melakukan pengecekan faktur dan surat pesanan	1. Melakukan ttd dengan menuliskan nama penerima, tanggal penerimaan dan nomor internal
2. Dilakukan pengkajian oleh PJ Gudang Farmasi		2. Petugas Gudang Farmasi melakukan pengecekan kesesuaian barang dengan Faktur	2. Mengambil 2 rangkap copy faktur, kemudian diinputkan penerimaan di SIMRS dan tanda terima input di <i>spreadsheets</i>
3. Meminta persetujuan Kains untuk melanjutkan proses pemesanan		3. Jika tidak sesuai, maka menghubungi pihak distributor terkait ketidaksesuaian	3. Mengirimkan 1 copy faktur beserta copy surat pesanan ke PT
4. Meminta persetujuan pengadaan PT dan Direktur PT		4. Melaporkan kepada Kains Farmasi dan membuat berita acara retur obat	
5. Mengirimkan surat pesanan ke distributor secara otomatis melalui SIMRS		5. Melakukan pencatatan untuk data Analisa bulanan	
		retrospektif Gudang	

2.4 Menentukan Dampak

Berikut merupakan hasil analisis kegagalan yang sering muncul pada saat melakukan proses penyerahan penerimaan barang disertai dengan efek dari dan penyebab dari kegagalan yang mungkin terjadi. Selanjutnya akan dilakukan analisis bentuk pengendalian yang dilakukan pada setiap kemungkinan kegagalan yang sering terjadi. Kemudian akan dilakukan penilaian dampak pada setiap sub proses yang dianalisis dengan ketentuan nilai sebagai berikut:

Tabel 2.5 penilaian dampak pada setiap sub proses

Penilaian Dampak		Penilaian Probabilitas		Penilaian Deteksi	
Skor	Dampak	Skor	Probabilitas	Skor	Deteksi
1	: Pasien tidak cedera	1	: Tidak mungkin Terjadi 6 kejadian selama 1 siklus (1 bulan)	1	Kuat : Kemungkinan terdeteksi 8 dari 8 kejadian
2	: Pasien cedera ringan, ada dampak yang harus di monitor	2	: Sangat Jarang Terjadi 4 kejadian selama 1 siklus (1 bulan)	2	Kurang : Kemungkinan terdeteksi 6 dari 8 kejadian
3	: Pasien terluka namun tidak sampai kehilangan fungsi, LOS memanjang	3	: Jarang Terjadi 2 kejadian dari 1 siklus (1 bulan)	3	Cukup : Kemungkinan terdeteksi 4 dari 8 kejadian
4	: Pasien terluka dan kehilangan fungsi permanen	4	: Mungkin Terjadi Beberapa kali dalam 1 siklus (1 bulan)	4	Kurang : Kemungkinan terdeteksi 2 dari 8 kejadian
5	: Pasien meninggal	5	: Sering Terjadi dalam 1 siklus (1 bulan)	5	Tidak Ada : Kemungkinan terdeteksi 0 dari 8 kejadian

Setelah dilakukan penilaian dampak, probabilitas dan deteksi, angka yang di dapatkan dikalikan seluruhnya. Hasil perkalian tersebut akan memunculkan rangking peringkat (RPN).

Tabel 2.6 Dampak Sub Proses Petugas Gudang Farmasi melakukan pengecekan faktur dan surat pesanan

Sub Proses : Melakukan pengecekan faktur dan surat pesanan								
No	Modus Kegagalan	Efek potensial dari kegagalan	Penyebab potensial dari kegagalan	Pengendalian yang sudah ada saat ini	Dampak	Probabilitas	Deteksi	RPN
1	Ketidaksesuaian surat pesanan dengan Faktur	Tidak bisa dilakukan proses penerimaan barang	Distributor salah dalam melakukan pengiriman barang	Pedoman Pengadaan Sedian Farmasi, Alkes, dan BMHP, SPO Penerimaan Barang	3	4	1	12

Tabel 2.7 Petugas Gudang Farmasi melakukan pengecekan kesesuaian barang dengan Faktur

Sub Proses : Melakukan pengecekan kesesuaian barang dengan Faktur								
No	Modus Kegagalan	Efek potensial dari kegagalan	Penyebab potensial dari kegagalan	Pengendalian yang sudah ada saat ini	Dampak	Probabilitas	Deteksi	RPN
1	Ada barang yang sub-standar/ rusak, kurang atau lebih	Tidak bisa dilakukan proses penerimaan barang	-Barang rusak saat proses pengiriman -Distributor salah saat penyiapan barang	Pedoman Pengadaan Sedian Farmasi, Alkes, dan BMHP, SPO Penerimaan Barang	4	4	1	16
2	Ada barang yang tidak sesuai stabiitas saat proses pengiriman	Tidak bisa dilakukan proses penerimaan barang	- Distributor tidak menaati CDOB	Pedoman Pengadaan Sedian Farmasi, Alkes, dan BMHP, SPO Penerimaan Barang	4	3	1	12

Tabel 2.8 Jika tidak sesuai, maka menghubungi pihak distributor terkait ketidaksesuaian

Sub Proses : Menghubungi pihak distributor terkait ketidaksesuaian								
No	Modus Kegagalan	Efek potensial dari kegagalan	Penyebab potensial dari kegagalan	Pengendalian yang sudah ada saat ini	Dampak	Probabilitas	Deteksi	RPN
1	Pihak distributor slow respon atau sulit dihubungi	Mempengaruhi ketersediaan obat di rumah sakit	- Distributor/sales masih dalam perjalanan -Terkendala sinyal	Pedoman Pengadaan Sedian Farmasi, Alkes, dan BMHP, SPO Penerimaan Barang	3	4	1	12

Tabel 2.9 Melaporkan kepada Kains Farmasi dan membuat berita acara retur obat

Sub Proses : Melaporkan kepada Kains Farmasi dan membuat berita acara retur obat								
No	Modus Kegagalan	Efek potensial dari kegagalan	Penyebab potensial dari kegagalan	Pengendalian yang sudah ada saat ini	Dampak	Probabilitas	Deteksi	RPN
1	Isi berita acara tidak sesuai dengan barang yang diretur	Tindak lanjut proses retur barang terhambat	-Ketidaktelitian -miss komunikasi antara petugas Gudang farmasi dan Kains	SPO Retur Barang, Berita acara ditandatangani oleh Kains dan petugas Gudang farmasi yang diketahui Kabid dan Direktur	3	4	1	12

Tabel 2.10 Melakukan pencatatan untuk data Analisa bulanan retrospektif Gudang

Sub Proses : Melakukan pencatatan untuk data Analisa bulanan retrospektif Gudang								
No	Modus Kegagalan	Efek potensial dari kegagalan	Penyebab potensial dari kegagalan	Pengendalian yang sudah ada saat ini	Dampak	Probabilitas	Deteksi	RPN
1	Tidak dilakukan pencatatan dan perekapan secara rutin	Tidak ada data perbaikan untuk bulan selanjutnya	Petugas tidak teliti	SPO Retur Barang	1	3	3	3

2.5 Prioritas Modus Kegagalan

Tabel 2.11 Deskripsi Prioritas Kegagalan dan Penilaian RPN

No	Modus Kegagalan	Efek potensial dari kegagalan	Penyebab potensial dari kegagalan	Pengendalian yang sudah ada saat ini	Dampak	Probabilitas	Deteksi	RPN
1	Ada barang yang sub-standar/ rusak, kurang atau lebih	Tidak bisa dilakukan proses penerimaan barang	-Barang rusak saat proses pengiriman	Pedoman Pengadaan Sedian Farmasi, Alkes, dan BMHP, SPO Penerimaan Barang	4	4	1	16
2	Ketidaksesuaian surat pesanan dengan Faktur	Tidak bisa dilakukan proses penerimaan barang	- Distributor salah dalam melakukan pengiriman barang	Pedoman Pengadaan Sedian Farmasi, Alkes, dan BMHP, SPO Penerimaan Barang	3	4	1	12
3	Ada barang yang tidak sesuai stabiitas saat proses pengiriman	Tidak bisa dilakukan proses penerimaan barang	- Distributor tidak menaati CDOB	Pedoman Pengadaan Sedian	4	3	1	12

				Farmasi, Alkes, dan BMHP, SPO Penerimaan Barang				
4	Pihak distributor slow respon atau sulit dihubungi	Mempengaruhi ketersediaan obat di rumah sakit	- Distributor/sales masih dalam perjalanan	Pedoman Pengadaan Sedian Farmasi, Alkes, dan BMHP, SPO Penerimaan Barang	3	4	1	12
5	Isi berita acara tidak sesuai dengan barang yang diretur	Tindak lanjut proses retur barang terhambat	-Ketidaktelitian	SPO Retur Barang, Berita acara ditandatangani oleh Kains dan petugas Gudang farmasi yang diketahui Kabid dan Direktur	3	4	1	12
6	Tidak dilakukan pencatatan dan perekapan secara rutin	Tidak ada data perbaikan untuk bulan selanjutnya	Petugas tidak teliti	SPO Retur Barang	1	3	3	3

2.6 Tindak Lanjut Risiko

Analisis Hazard											Identifikasi Tindakan				
Modus Kegagalan				Skor Hazard			Analisis Pohon Keputusan				Tipe Tindakan (Kontrol, Terima, Eliminasi)	Rekomendasi Tindakan Untuk Menghentikan	Ukuran Outcome	PJ	Perstujuan Manajemen
				Dampak	Probabilitas	Nilai Hazard	Poin Tunggal Kelemahan?	Ada Ukuran Kontrol?	Kemudahan Dideteksi?	Re-desain?					
1	Ada barang yang sub-standar/ rusak, kurang atau lebih														
		1	Barang rusak saat proses pengiriman	3	3	9	N	N	N	Y	Kontrol	Supervisi		Kepala IFRS	Y
2	Ketidaksesuaian surat pesanan dengan Faktur														
		2	Distributor salah dalam melakukan	4	2	8	N	N	N	Y	Kontrol	Supervisi		Kepala IFRS	Y

			pengiriman barang												
3	Ada barang yang tidak sesuai stabiitas saat proses pengiriman														
		3	Distributor tidak menaati CDOB	4	2	8	N	N	N	Y	Kontrol	Supervisi		Kepala IFRS	Y
4	Pihak distributor slow respon atau sulit dihubungi														
		4	Distributor/sales masih dalam perjalanan/off	2	2	4	N	N	N	Y	Kontrol	Supervisi		Kepala IFRS	Y
5	Isi berita acara tidak sesuai dengan barang yang diretur														
		5	Ketidakteitian petugas	3	2	6	N	N	N	Y	Kontrol	Supervisi		Kepala IFRS	Y
6	Tidak dilakukan pencatatan dan perekapan secara rutin														
		6	Ketidakteitian petugas	3	3	9	N	N	N	Y	Kontrol	Supervisi		Kepala IFRS	Y

2.7 Aksi Mitigasi Risiko

No Risk	Divisi	Petugas terkait	Pemilik Risk	Tipe Risk	Deskripsi Risk	Pengendalian yang sudah ada	Skor Risk Sebelumnya	Dampak	Kemungkinan	Status Perubahan Rating Risiko	Mitigasi yang sedang dijalankan	Target Penyelesaian	Target Skor Risk	Indikator Kunci Mitigasi	Rencana Review
1	IFRS	Kepala Gudang dan Kepala IFRS	Gudang IFRS	Proses	Ada barang yang sub-standar/ rusak, kurang atau lebih	Kontrol dan supervisi	16	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan	6	Barang pesanan tidak ada yang rusak	Check list barang
2	IFRS	Kepala Gudang dan Kepala IFRS	Gudang IFRS	Proses	Ketidaktepatan surat pesanan dengan Faktur	Kontrol dan supervisi	12	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan	6	Kesesuaian pesanan dengan barang satabf	Check list barang
3	IFRS	Kepala Gudang dan Kepala IFRS	Gudang IFRS	Proses	Ada barang yang tidak sesuai stabilitas saat proses pengiriman	Kontrol dan supervisi	12	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan	6	SPO pengiriman dan penerimaan barang	Check list barang

4	IFRS	Kepala Gudang dan Kepala IFRS	Gudang IFRS	Proses	Pihak distributor slow respon atau sulit dihubungi	Kontrol dan supervisi	12	Ekstrim	Mungkin	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan	4	-	Check list barang
5	IFRS	Kepala Gudang dan Kepala IFRS	Gudang IFRS	Proses	Isi berita acara tidak sesuai dengan barang yang diretur	Kontrol dan supervisi	12	Ekstrim	Mungkin	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan	4	-	Check list barang
6	IFRS	Kepala Gudang dan Kepala IFRS	Gudang IFRS	Proses	Tidak dilakukan pencatatan dan perekapan secara rutin	Kontrol dan supervisi	3	Rendah	Mungkin	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan	4	Serah terima barang datang	Check list barang

BAB III PENUTUP

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) merupakan teknik yang berbasis tim, sistematis, dan proaktif yang digunakan untuk mencegah permasalahan dari proses atau produk sebelum permasalahan tersebut muncul/terjadi. Dengan dilakukannya metode FMEA di Gudang Farmasi ini, diharapkan dapat mengurangi kemungkinan kesalahan-kesalahan yang terjadi saat melakukan penerimaan barang di Gudang di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo. Sehingga tercipta suatu pelayanan yang bermutu dan terjaminnya ketersediaan obat di unit terkait.

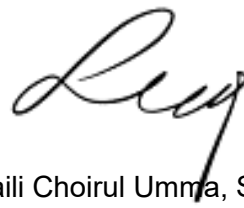
Pasuruan, 1 November 2025

Menyetujui,
Ketua Komite Mutu



Lidia Kencana, S.KM

Penyusun,
Kepala Instalasi Farmasi



apt Laili Choirul Umma, S. Farm

Mengetahui,
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns.Heni Indra Wulansari,S.Kep,M.Kep